Antibióticos · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Sepse [SSC] [AWaRe]

Choque: ATB em até 1 h; sepse provável: até 3 h. Hemocultura sem atrasar. AWaRe: ampicilina 50 mg/kg 8/8 h + gentamicina 7,5 mg/kg 1×/dia, ou ceftriaxona 80 mg/kg 1×/dia (máx. 3 g).

Meningite [MS-GVS]

> 2 meses	Ceftriaxona 100 mg/kg/dia 12/12 h ou cefotaxima 200 mg/kg/dia 6/6 h
< 2 meses	Ampicilina + cefotaxima (ou + aminoglicosídeo); sem ceftriaxona no neonato
Pneumococo R	Vancomicina 60 mg/kg/dia 6/6 h + C3G; nunca sozinha
Duração	Meningococo 5–7 d · pneumococo 10–14 · Hi 7–10 · BGN 21

Profilaxia de contatos [MS-NT]

Meningococo	Rifampicina 10 mg/kg/dose (máx. 600) 12/12 h, 2 d · < 1 m 5 mg/kg · ceftriaxona IM 125 mg (< 12 a) / 250 mg
Hib	Rifampicina 20 mg/kg/dose (máx. 600) 1×/dia, 4 d · < 1 m 10 mg/kg

ITU [SBP-ITU]

Coleta: cateterismo/punção sem controle esfincteriano; saco coletor positivo se confirma. Cortes: punção qualquer · cateter > 1.000 · jato > 50–100 mil.

Febril VO	Cefuroxima 30 mg/kg/dia 12/12 h · 10 dias
Febril IV	Cefuroxima 150 mg/kg/dia 8/8 h · gentamicina 5–7,5 mg/kg/dia 1×
Afebril	Nitrofurantoína 5–7 mg/kg/dia 6/6 h · cefalexina 50 mg/kg/dia
Internar	< 2 meses, grave, sem adesão

Vias aéreas [AIDPI] [ABORL] [SBP-PAC]

Amoxicilina: OMA 50 mg/kg/dia 8 d · faringite 50, 10 d (benzatina < 20 kg 600 mil, ≥ 20 kg 1,2 milhão) · sinusite 25–50, 7–10 d · PAC 50 (máx. 4 g), 7 d. PAC internada: ampicilina 50 mg/kg/dose 6/6 h.

Pele e disenteria [AWaRe] [MS-DIA]

Celulite leve: cefalexina 25 mg/kg/dose 12/12 h, ~5 d; abscesso: drenar. Disenteria ≤ 30 kg, ≥ 3 m: azitromicina 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg D2–D5; > 30 kg: ciprofloxacino 500 mg 12/12 h, 3 d.

Não fazer

Atrasar ATB por exame · ceftriaxona no neonato · vancomicina isolada · nitrofurantoína com febre · tratar saco coletor · confundir mg/kg/dia com /dose.